Allergies aux Bêta-lactamines : recommandations pour la pratique clinique

Diaporama du groupe SPILF recommandations d'après les recommandations Européennes : "ESCMID Clinical Guidelines on the Evaluation and Management of a Reported Antibiotic Allergy (doi: 10.1016/j.cmi.2026.02.011.)" publiées en février 2026 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41707748/

Réalisé le 8.4.2026

Définitions : allergie grave vs non grave (1)

Définitions	Symptômes présentés	Type de réaction
Grave	Réaction cutanée (ex : urticaire généralisée) et/ou muqueuse ou cutanéo-muqueuse AIGUE (survenant quelques minutes à quelques heures après l'exposition) **ET** un des symptômes suivant parmi : A. signes de défaillance respiratoire : dyspnée, bronchospasme, stridor, frein expiratoire, désaturation… B. Signes de défaillance hémodynamique avec hypotension ou défaillance d'organe (syncope, hypotonie, arrêt circulatoire, arrêt respiratoire…)	HSI
	Hypotension ou bronchospasme ou œdème laryngé aigue après une exposition à un allergène connu ou suspecté (quelques minutes à quelques heures après l'exposition), même en absence de réaction cutanée ou muqueuse typique	HSI
	Effets secondaires cutanés graves parmi : A. Apparition de vésicules ou croûtes, de couleur gris-violacé, douloureuses ou aspect de brûlures de la peau et/ou des muqueuses avec fièvre et sensation de malaises, apparition de lésions érosives hémorragiques des muqueuses, apparition d'un décollement de la peau (sd de Stevens Johnson, épidermolyse nécrosante suraiguë de Lyell) B. PEAG C. Purpura (vascularite) D. EMP avec atteinte > 50% de la surface corporelle, et/ou atteinte des muqueuses, et/ou présence d'un purpura, et/ou décollement ou bulle, et/ou œdème de la face, et/ou signes systémiques associés (fièvre, éosinophilie >0.5G/L, atteinte d'organes (cytolyse hépatique, insuffisance rénale…) (DRESS) E. Œdème de la face, éruption œdémateuse et infiltration cutanée. Fièvre ≥ 38.5° (PEAG, DRESS)	HSR

HSI : hypersensibilité immédiate, HSR : hypersensibilité retardée, PEAG : pustulose exanthématique aigue généralisée, EMP :

Définitions : allergie grave vs non grave (2)

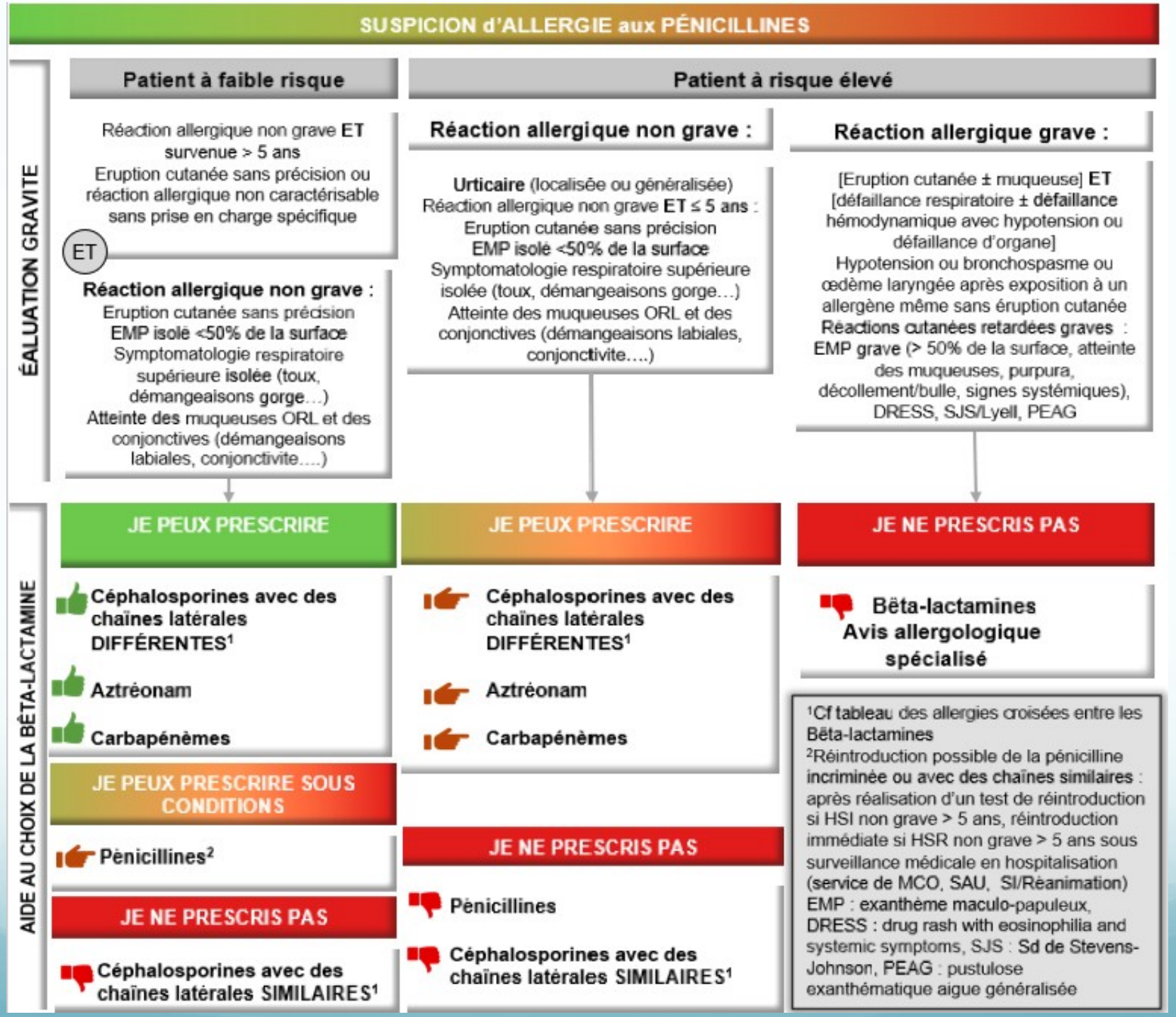
Définitions	Symptômes présentés	Type de réaction
Non grave	Réaction cutanée : éruption cutanée sans précision, urticaire localisée, érythème-chaleur, prurit, EMP isolé <50% surface corporelle ET sans signes systémiques associés	Urticaire= HSI EMP isolé=HSR
	Symptomatologie respiratoire supérieure : démangeaisons dans la gorge, toux sans bronchospasme, rhinorrhée, congestion nasale, prurit nasal, éternuements	
	Atteinte des muqueuses de la sphère ORL (picotements/démangeaisons des lèvres) et des conjonctives (conjonctivite, prurit)	
	Autre : symptomatologie gastro-intestinale (nausées ± vomissements répétés, goût métallique)	

HSI : hypersensibilité immédiate, HSR : hypersensibilité retardée, EMP : exanthème maculo-papuleux

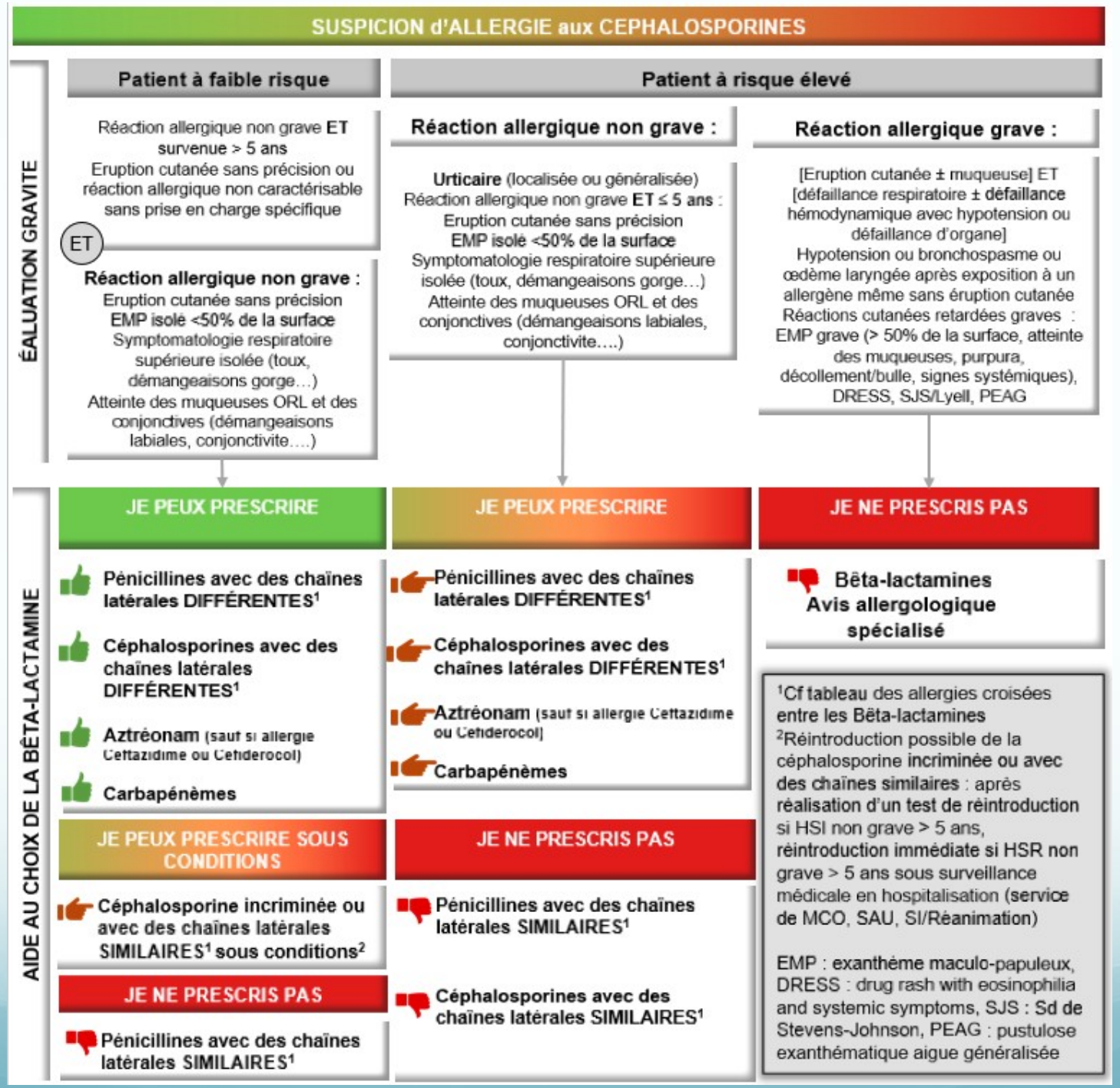
Stratification du risque allergique

Evaluation du risque	Symptômes présentés	Attitudes
Groupe à haut risque de présenter une allergie	Urticaire (isolée, généralisée ou localisée) Réaction allergique non grave **ET** survenue ≤ à 5 ans	Avis/cs en allergologie. Prescription possible d'une céphalosporine avec des chaînes différentes* ou d'un monobactam (contre-indication si allergie ceftazidime/cefidérocol) ou d'un carbapénème
	Réaction allergique grave	Avis/cs en allergologie Contre-indication aux Bêla-ctamines
Groupe à faible risque de présenter une allergie	• Réaction cutanée/allergique non grave (sauf urticaire) **ET** survenue > à 5 ans • Eruption cutanée sans précision ET absence de signes de gravité (absence d'hospitalisation ou de traitement médical spécifique pour l'allergie) • Réaction allergique non caractérisable ET absence de signes de gravité (absence d'hospitalisation ou de traitement médical spécifique pour l'allergie)	Test de réintroduction Prescription possible d'une céphalosporine avec des chaînes différentes* ou d'un monobactam (contre-indication si allergie ceftazidime/cefidérocol) ou d'un carbapénème
Groupe à très faible risque de présenter	• Antibiotique incriminé réintroduit et bien toléré • Suspicion reposant uniquement sur des antécédents familiaux ou la crainte • Symptômes incompatibles avec une réaction allergique	Pas de tests allergologiques Pas de test de réintroduction L'ensemble des Bêta-lactamines sont utilisables y

e de prise en charge suspicion d'allergie aux pénicillin es



Prise en charge suspicion d'allergie aux céphalosporines



CAT en cas d'allergie « groupe à faible risque de présenter une allergie»

Famille	CAT/Alternatives
Pénicilline	Pénicilline incriminée : HSI non grave > 5 ans : test de réintroduction HSR non grave > 5 ans : réintroduction directe possible
	Autres pénicillines : HSI non grave > 5 ans : test de réintroduction HSR non grave > 5 ans : autres pénicillines possibles
	Céphalosporines avec des chaînes latérales différentes* Monobactam Carbapénèmes
Céphalosporine	Pénicillines avec des chaînes latérales différentes*
	Céphalosporine incriminée ou avec des chaînes latérales similaires* : HSI non grave > 5 ans : test de réintroduction HSR non grave > 5 ans : réintroduction directe possible
	Céphalosporines avec des chaînes latérales différentes* Monobactam avec des chaînes latérales différentes* (contre-indication si allergie ceftazidime/céfidérocol) Carbapénèmes

HSI : hypersensibilité immédiate, HSR : hypersensibilité retardée, EMP : exanthème maculo-papuleux
* Cf tableau des allergies croisées diapositive 9

CAT en cas d'allergie « groupe à haut risque de présenter une allergie»

Famille	CAT/ Alternatives
Pénicilline	Pénicilline incriminée : avis/cs allergologique Autres Pénicillines : avis/cs allergologique
	Céphalosporines avec des chaînes latérales différentes* Monobactam Carbapénèmes
Céphalosporine	Pénicillines avec des chaînes latérales différentes*
	Céphalosporine incriminée ou avec des chaînes latérales similaires : avis/cs allergologique
	Céphalosporines avec des chaînes latérales différentes* Monobactam avec des chaînes latérales différentes* (contre-indication si allergie ceftazidime/céfidérocol) Carbapénèmes

HSI : hypersensibilité immédiate, HSR : hypersensibilité retardée, EMP : exanthème maculo-papuleux
* Cf tableau des allergies croisées diapositive 9

Tableau des allergies croisées

	Amoxicilline	Pénicilline G	Pénicilline v	Flucloxacilline	Pipéracilline	Céfalexine	Céfazoline	Céfalotine	Céfuroxime	Céfaclor	Céfamandole	Ceftriaxone	Céfotaxime	Ceftazidime	Céfépime	Céfidérocol	Ceftaroline	Ceftolozane	Méropénème	Imipénème	Ertapénème	Aztréonam
Amoxicilline							v	v	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Pénicilline G							v	v	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Pénicilline v							v	v	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Flucloxacilline						v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Pipéracilline							v	v	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Céfalexine				v			v	v	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Céfazoline	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Céfalotine	v	v	v	v	v	v	v			v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v
Céfuroxime	v	v	v	v	v	v	v			v	v								v	v	v	
Céfaclor				v			v	v	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Céfamandole				v			v	v	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Ceftriaxone	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v								v	v	v	
Céfotaxime	v	v	v	v	v	v	v			v	v								v	v	v	
Ceftazidime	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v								v	v	v	
Céfépime	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v								v	v	v	
Céfidérocol	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v								v	v	v	
Ceftaroline	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v								v	v	v	
Ceftolozane	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v								v	v	v	
Méropénème	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				v
Imipénème	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				v
Ertapénème	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				v
Aztréonam*	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v								v	v	v	
Legende	*	Céphalosporines Vs Aztréonam : risque d'allergies croisée cliniquement rapportés si allergie à la ceftazidime et au céfidérocol																				
		Allergie possible via les PPL (penicilloyl polylysine = déterminant majeur des pénicillines)																				
		Risque d'allergie croisée via une chaine latérale identique R1 ou R2																				
		Risque d'allergie croisée via une chaine latérale similaire R1 ou R2 ou selon les études cliniques																				
	v	Pas de risque d'allergie croisée																				

Test de réintroduction

- Information et consentement du patient

- Méthode :
  - Appliquer le protocole en vigueur dans votre établissement s'il existe
  - En l'absence de protocole, deux méthodes peuvent être utilisées :
    - dose unique : administrer 100 % de la dose complète de l'antibiotique de référence, de préférence par voie orale, ou par une autre voie si nécessaire. Si le médicament de référence est inconnu mais qu'il s'agit probablement d'une pénicilline, il convient d'utiliser de l'amoxicilline (500 mg pour les adultes)
    - doses graduées : administrer 10 % de la dose complète de l'antibiotique de référence (c'est-à-dire 50 mg d'amoxicilline pour les adultes); observer pendant 30 minutes ; administrer 50 % de la dose complète de l'antibiotique de référence (c'est-à-dire 250 mg d'amoxicilline pour les adultes); observer pendant 30 minutes; administrer le reste de la dose complète de l'antibiotique de référence (c'est-à-dire 200 mg d'amoxicilline pour les adultes); surveillance pendant 60 minutes.

- Surveillance médicale pendant 1 heure après la dernière dose dans un environnement assurant la possibilité prendre en charge une réaction d'hypersensibilité.

- Contre-indication : maladie pulmonaire chronique sévère ou décompensée, maladie cardiaque chronique sévère (notamment sténose aortique), femme enceinte,